Tableau 1 Patients immunisés ($n = 3399$).

		Hommes (n = 1204)	Femmes (n = 2195)	p
Transfusion (CGR/patient)		27,8	21,0	< 0,001
Immunisation		2,25%	3,17%	< 0,001
Anticorps (%)				
RH-KEL	D	10	17,7	< 0,001
	E	24,5	22	NS
	K	21,1	20,3	NS
	C	6,2	8,3	0,032
	c	3,5	5,1	0,040
	e	1	0,8	NS
FY	Fya	9,7	10,2	NS
	Fyb	0,8	0,8	NS
JK	Jka	14,4	12,3	NS
	Jkb	2,9	4,0	NS
LE	Lea	2,5	1,5	0,053
	Leb	0,7	0,2	0,047
MNS	M	4,4	1,9	< 0,001
	S	3,6	3,7	NS
LU	Lua	4,7	2,9	0,009
	Lub	0	0,1	NS

Déclaration d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet article.

Références

[1] Ameen R, et al. Frequency of red blood cell alloantibody in Kuwaiti population. Med Princ Pract 2005;14:230–4.

[2] Aygun B, et al. Clinical significance of RBC alloantibodies and autoantibodies in sickle cell patients who received transfusions. Transfusion 2002;42:37–43.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.06.033

P032

Évaluation de l'efficacité transfusionnelle des CPA au CHU d'Annaba

I. Frigaa [1,*], B. Rached [2], H. Mahnaoui [2], S. Laifaoui [1], H. Ouelaa [1]

[1] *CHU d'Annaba, faculté de médecine, Annaba, Algérie*

[2] *Service d'hématologie, hôpital Dorban, CHU d'Annaba, Annaba, Algérie*

* *Auteur correspondant.*

Adresse e-mail : ifrigaa@yahoo.fr (I. Frigaa)

L'évaluation du rendement transfusionnel plaquettaire est un outil de dépistage des différents facteurs influençant l'efficacité transfusionnelle.

Notre étude évalue le rendement transfusionnel plaquettaire afin d'analyser les principales causes d'inefficacités transfusionnelle.

Il s'agit d'une étude prospective réalisée sur une durée de 6 mois, évaluant l'efficacité transfusionnelle de 111 transfusions plaquettaires de CPA chez 64 patients thrombopéniques suivi pour leucémie aiguë, aplasie médullaire.

Les résultats montrent que le rendement transfusionnel plaquettaire est efficace à 80,71 % et inefficace dans 27 cas soit un pourcentage de 19,28 %.

L'étude des facteurs influençant ce rendement inefficace démontre que : la fièvre, l'antibiothérapie, l'hémorragie, la splénomégalie et la dose plaquettaire insuffisante sont responsable de la réduction de ce rendement.

L'évaluation de rendement transfusionnel plaquettaire est donc un moyen très utile pour le clinicien et le médecin transfuseur afin d'adopter de meilleurs conditions de transfusion plaquettaire.

Déclaration d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet article.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.06.034

P033

Automatisation de la production des PSL par le procédé Atreus® de Terumo BCT : une révolution en matière de qualité et de sécurité transfusionnelle au Maroc

M. Hakam [1,*], K. Hajjout [2], M. Benajiba [1]

[1] *Centre national de transfusion sanguine et d'hématologie (CNTSH), Rabat, Maroc*

[2] *Centre régional de transfusion sanguine (CRTS), Rabat, Maroc*

* *Auteur correspondant.*

Adresse e-mail : hakak112000@yahoo.fr (M. Hakam)

Introduction Le système ATREUS® (Terumo BCT) automatise la préparation de trois (ou deux) composants sanguins à partir d'un don de sang total.

Dans le cadre de la nouvelle stratégie de développement de la transfusion marocaine, le CNTSH a lancé en 2013 un projet pilote : « Automatisation de la production des PSL ».

Objectifs Correction des dysfonctionnements soulevés par le projet état des lieux transfusion marocaine (2010).

Méthodologie En janvier 2015, le CRTS de Rabat a basculé une partie de sa production en technique automatique ATREUS® (Terumo BCT) dans le cadre d'un projet pilote de séparation de 15 000 poches. Une étude comparative attestant les avantages du procédé en matière de contrôle de qualité des PSL est menée : elle montre des améliorations spectaculaires en matière de la qualité et de la quantité des plaquettes. Les concentrés de globules et les plasmas sont très satisfaisants.

Dans un premier temps, seules, les poches prélevées au niveau du site fixe sont séparées automatiquement. Après la maîtrise de la technologie et son acceptation par les équipes, un second temps est marqué par la décision de passer à une automatisation de toute la production du CRTS de Rabat.

Conclusion Pour le receveur, les avantages sont évidents : les trois produits sanguins sont leuco-réduits, et leur effet thérapeutique est meilleure.

Pour le CNTSH la généralisation de ce projet permet de corriger l'écart de standardisation des paramètres des trois composants sanguins à l'échelle nationale et d'optimiser les ressources humaines.

Pour le système de santé, cette démarche contribue à améliorer la performance des soins de santé marocains.

Déclaration d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet article.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.06.035

04. Sécurité transfusionnelle infectieuse (agents transmissibles par le sang, épidémiologie, diagnostic, prévention)

P034

Évolution du risque résiduel (RR) de transmission du VIH au Centre national de transfusion sanguine (CNTS) de Lomé (Togo) de janvier 2008 à décembre 2012

L. Nadjir [1], H. Magnang [1], K. Mawussi [1], L. Feteke [1,*], D.W. Maba [1], A.Y. Segbena [1], J.P. Cazenave [2]
[1] *CNTS, Lomé, Togo*
[2] *Établissement français de sang Alsace, Strasbourg, France*
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : fetekeloch@hotmail.com (L. Feteke)

Objectifs Les objectifs sont :
– d'analyser le risque résiduel transfusionnel du VIH au CNTS de Lomé (Togo) ;
– de proposer les orientations futures pour renforcer la sécurité transfusionnelle.
Méthodologie Le risque résiduel a été estimé chez des donneurs de sang total, bénévoles et réguliers par la méthode indirecte de SCHREIBER qui estimait le risque qu'un don soit fait durant la période immunologiquement silencieuse. À partir des cas incidents, nous avons calculé les taux d'incidence du VIH, qui, multipliés par la durée de la fenêtre sérologique donnaient le risque résiduel de transmission.
Résultats Les donneurs de sang répondant aux critères d'inclusion de notre étude étaient au nombre de 16 042. Les hommes représentaient 79,37 % et 64,41 % avaient moins de 30 ans. Le nombre de cas de VIH confirmés était de : zéro en 2008, cinq en 2009, cinq en 2010, trois en 2011, deux en 2012. Le risque résiduel était respectivement de 1/17 391 en 2009, 1/19 342 en 2010, 1/43 478 en 2011 et 1/181 818 en 2012. De 2009 à 2012 le risque résiduel avait diminué de 10,45 fois.
Conclusion Le risque résiduel du VIH était relativement élevé en 2009 mais avait progressivement diminué de plus de dix fois en 2012. La fidélisation des donneurs et l'orientation du CNTS de Lomé vers de nouvelles technologies telle que l'inactivation des pathogènes contribuerait à réduire sensiblement le risque résiduel des maladies transmises par le sang.
Mots clés Risque résiduel ; VIH ; Transfusion ; Togo

Déclaration d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet article.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.06.036

P035

Plan de formation déployé suite à la mise en place d'une nouvelle carte de contrôle pré-transfusionnel

J.C. Gouiry*, V. Carpin, I. Kodzaga
CHU Nord la Réunion, Saint-Denis, Réunion
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : jcgouiry@gmail.com (J.C. Gouiry)

Mars 2014, l'EFS signale qu'il distribuera une nouvelle carte de CUPT en 2015. Dés le mois d'avril le fabricant s'associe à des sessions d'enseignement qui concerneront 17 PH, 5 IDE, 3 IADE. L'IADE affectée à l'hémovigilance reçoit une formation approfondie pour devenir référent. Des actions dans les salles de soins et des séances institutionnelles sont débutées, des posters affichés et des check-list remises dans chaque service. Cent quatre-vingt-seize personnes sont opérationnelles au lancement du nouvel outil au 01/07. Trois signalements de tests défectueux montrent que des IDE formées par leurs collègues ont commis des erreurs d'humidification. Une mauvaise homogénéisation des boudins de sang ainsi qu'un dépôt excessif dans les puits sont retrouvés comme cause de doute. Devant ces faits une fiche d'EI est remplie. Grâce au soutien de la cellule qualité et de la Direction des Soins, les CS seront informés du caractère obligatoire de la formation qui aura lieu dorénavant dans un local dédié. Pour gérer les convocations, la décision de disposer de la liste des effectifs sera prise lors d'un CSTH. Ce travail sera mené par l'IADE 1/2 temps puis temps plein. Les séances ont duré 1 h et ont permis de rappeler les bonnes pratiques. Les IMG 1er semestre sont formés par le CHV. Au 31/12, 558 IDE ont été vus et aucun dysfonctionnement signalé. Des nouvelles remarques sont notées :
– manque de consigne pour conserver la partie détachable ;
– difficulté de lire les caractères.
Une 1re évaluation a permis de recueillir sur 136 retours 7,4 % d'avis défavorables. Cette nouvelle pratique, une fois maîtrisée grâce à un gros effort de formation, a donc été intégrée par la majorité des IDE.

Déclaration d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet article.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.06.037

P036

Validation de la méthode de détection des virus hépatite A, hépatite E et du parvovirus B19 par PCR en temps réel dans les pools de plasma humain traités pour viro-inactivation par solvant-détergent (PL-SD)

M. Lapeyre, F. Auvray, H. Thevenin, S. Perrollet, N. Delesalle*
ANSM, Saint-Denis, France
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : nathalie.delesalle@ansm.sante.fr (N. Delesalle)

Suite à un changement de réglementation, tous les PL-SD sont soumis au processus de libération de lot selon le *guideline* européen comprenant la réalisation des tests de détection des virus HAV, HEV, B19 et HCV. Dans ce contexte, une validation de la méthode de détection des virus HAV, HEV et du parvovirus B19 par PCR en temps réel dans les pools de PL-SD a été réalisée dans le but d'être en mesure de libérer les lots de ces produits.
Cette méthode a pour principe une extraction combinée pour les trois marqueurs viraux avec l'équipement EasyMAG puis une amplification détection commune pour HAV et HEV (deux virus ARN) et une autre pour B19 (virus ADN) avec l'équipement Light Cycler 480. Les kits utilisés sont les kits d'amplification ALTONA Realstar HAV PCR et HEV PCR ainsi que le kit Argène Parvovirus B19 R-gene. Les déterminations de la robustesse et la limite de détection ainsi que l'établissement d'un contrôle qualité interne pour le HAV, HEV et B19 ont été réalisés. La linéarité, la précision et l'exactitude ont été ajoutées pour le B19. La méthode de détection de l'HAV et l'HEV est un test qualitatif (présence/absence). La méthode de détection du B19 est un test semi-quantitatif (critère de conformité $< 10^4$ UI/mL).
La robustesse n'a pas mis en évidence de contamination croisée. Les limites de détection ont été déterminées. Les bornes des différents contrôles de qualité interne ont été définies. Pour le B19, la linéarité et la précision et l'exactitude ont été évaluées.

Déclaration d'intérêts Les auteurs déclarent ne pas avoir de conflits d'intérêts en relation avec cet article.

http://dx.doi.org/10.1016/j.tracli.2015.06.038

P037

Étude de faisabilité pour l'utilisation des trousses HAV, HAV et B19 sur l'automate LC 480, dans le cadre du contrôle des pools de plasma humain traités pour viro-inactivation par solvant-détergent (PL-SD)

M. Lapeyre, F. Auvray, N. Delesalle*, I. Fabre
ANSM, Saint-Denis, France
* *Auteur correspondant.*
Adresse e-mail : nathalie.delesalle@ansm.sante.fr (N. Delesalle)

Objectif Tester les performances de trousses HAV, HEV et B19 sur l'automate LC 480 dans le cadre du contrôle des pools de PL-SD.
Méthode Les kits d'amplification ALTONA Realstar HAV PCR, HEV PCR et B19 PCR ainsi que le kit Argène Parvovirus B19 R-gene ont été testés. Le but était premièrement de tester chaque kit indépendamment et deuxièmement de tester ces kits en réalisant une extraction combinée pour les trois marqueurs viraux avec l'équipement EasyMAG puis une amplification détection avec l'équipement LC 480. Conformément à la monographie de la pharmacopée européenne 1646 des PL-SD, un témoin positif à taux déterminé doit être inclus dans chaque série. Cette étude a permis de vérifier la bonne détection de ces témoins. Afin d'étudier les interférences entre les différents taux de virus, des échantillons composés de mélange de 2 virus ont été également testés. Ces essais ont été réalisés avec les standards du WHO B19, HAV et HEV.
Résultats Pour l'HAV, le B19 et l'HEV, les essais ont permis de détecter le témoin positif comme attendu. Pour le B19, une différence de sensibilité entre